TÓM TẮT LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 1 Các thời kỳ tuổi trẻ

Tóm tắt từ tài liệu Các thời kỳ tuổi trẻ.pdf (9 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa - Offline

1. THỜI KỲ BÀO THAI
2. THỜI KỲ SƠ SINH
3. THỜI KỲ NHŨ NHI
4. THỜI KỲ RĂNG SỮA
5. THỜI KỲ THIẾU NHI
6. THỜI KỲ THIẾU NIÊN

Tuổi trẻ chia thành **6 thời kỳ**: bào thai, sơ sinh, nhũ nhi, răng sữa, thiếu nhi, thiếu niên. Mỗi thời kỳ có đặc điểm sinh lý, bệnh lý và cách phòng bệnh riêng, kể cả trong chăm sóc răng miệng.

Thời kỳ	Thời gian
Bào thai	Trung bình **38 tuần** (280 ± 15 ngày) từ lúc thụ tinh
Sơ sinh	**28 ngày đầu** sau sinh
Nhũ nhi	Từ **tháng thứ 2 đến tháng thứ 12**
Răng sữa	Từ **1 đến 6 tuổi** (nhà trẻ 1–3 tuổi, mẫu giáo 4–6 tuổi)
Thiếu nhi	Từ **7 đến 11 tuổi** (tuổi học đường)
Thiếu niên	Từ **12 đến 18 tuổi**, có thể kéo dài đến 20 tuổi

1. THỜI KỲ BÀO THAI

1.1. Giai đoạn phôi (8 tuần đầu)

- **Sinh lý:** giai đoạn **tượng hình** các bộ phận; tế bào tăng chủ yếu về **số lượng**, thai tăng cân ít nhưng dài ra nhanh. Cuối tuần 8, chiều dài đầu – mông khoảng **3 cm**, các hệ cơ quan cơ bản đã thiết lập.
- **Mầm răng sữa** hình thành ngay trong **3 tháng đầu**; mầm xoang cạnh mũi (như xoang hàm) xuất hiện từ **tuần thứ 8**.
- **Bệnh lý:** cực kỳ nhạy cảm với tác nhân độc hại → **sẩy thai, quái thai, dị tật bẩm sinh**. Yếu tố nguy cơ:
  - Độc chất: dioxin, thủy ngân, thalidomide, rượu, khói thuốc lá.
  - Thuốc: an thần, kháng sinh, nội tiết tố, chống động kinh, chống ung thư.
  - Nhiễm siêu vi: cúm, rubella, nhóm TORCH.
  - Tác nhân vật lý: tia X, chất phóng xạ.
- **Phòng ngừa:** giáo dục tiền hôn nhân, tầm soát dị tật tiền sản, tránh nguồn lây và chất độc, chỉ dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ.

1.2. Giai đoạn thai (tuần 9 đến khi sinh)

- **Sinh lý:** tăng trưởng và biệt hóa nhanh các mô, cơ quan.
  - **Tuần 10:** khuôn mặt có nét cơ bản. **Tuần 12:** phân biệt giới tính ngoài, phổi có mầm phế quản.
  - **Tuần 20–24:** xuất hiện phế nang nguyên phát, bắt đầu tổng hợp **surfactant**.
  - **Tam cá nguyệt 3:** tích lũy mạnh calcium, sắt, đạm, mỡ; chiều dài tăng gấp đôi, cân nặng tăng gấp ba; cân nặng lúc sinh trung bình **3.000 g** (2.500–3.500 g).
  - Thần kinh: sau tuần 8 các cấu trúc chính đã thiết lập, synapse hình thành rất nhanh nên hệ thần kinh **rất nhạy cảm với thiếu oxy**.
  - Tâm lý: gắn kết mẹ – con rõ khi mẹ cảm nhận **cử động thai (khoảng tuần 20)**.

- **Bệnh lý:** mẹ tăng cân kém → **suy dinh dưỡng bào thai**; tam cá nguyệt cuối hàng rào nhau thai giảm bảo vệ → dễ **sinh non, nhiễm trùng**; mẹ sang chấn tâm lý kéo dài → trẻ nhẹ cân, sinh non, vòng đầu nhỏ, tăng nguy cơ ADHD, ám ảnh cưỡng chế.
- **Phòng ngừa:** khám thai định kỳ, tiêm ngừa đủ, dinh dưỡng đầy đủ, tránh lo âu và nguồn lây.

2. THỜI KỲ SƠ SINH

- **Thời gian: 28 ngày đầu** sau sinh.
- **Sinh lý:** "cuộc cách mạng" thích nghi: tự thở, tự tuần hoàn, tự tiêu hóa. **Sữa non** là thức ăn đầu tiên và lý tưởng nhất: nhiều đạm, globulin miễn dịch (chủ yếu **IgA**), giàu **vitamin A**. Tiếp xúc **da kề da** giúp bú sớm, bú lâu và gắn kết mẹ – con.
- **Bệnh lý:** thời kỳ **tử vong cao nhất**: tử vong sơ sinh chiếm **47%** tử vong trẻ dưới 5 tuổi (WHO 2017), **75%** trong đó xảy ra trong **24 giờ đầu**. Dễ bị sang chấn sản khoa (xuất huyết não – màng não, sinh ngạt, gãy xương đòn) và nhiễm trùng sơ sinh nặng (nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm phổi).
- **Phòng ngừa:** sản phụ tiêm ngừa **uốn ván**, sinh tại cơ sở y tế đủ trang thiết bị, da kề da, cho bú sữa non **trong 60 phút đầu**, theo dõi sát trẻ nguy cơ cao.

3. THỜI KỲ NHŨ NHI

- **Thời gian: tháng 2 đến tháng 12**.
- **Sinh lý:** tăng trưởng thể chất và tâm vận động **mạnh nhất**; tạo hình và liên kết neuron đạt đỉnh.
  - Mốc **12 tháng:** thể tích não gấp đôi (khoảng **72%** não người lớn), cân nặng **gấp 3** lúc sinh, chiều dài tăng **25 cm** (khoảng **75 cm**), vòng đầu tăng **10 cm** (khoảng **44 cm**).
  - Nhu cầu năng lượng **120–130 kcal/kg/ngày** (gấp 3 người lớn) → sau 6 tháng sữa mẹ đơn thuần không đủ.
  - Miễn dịch: **IgG** từ mẹ qua nhau thai, **IgA** qua sữa mẹ; cạn dần sau **6 tháng**.
  - **Mọc răng:** bắt đầu khoảng **6 tháng**; răng đầu tiên thường là **2 răng cửa hàm dưới**; 6–12 tháng mọc đủ **8 răng cửa**. Ăn dặm đặc dần, cứng dần từ tháng 6 giúp tập nhai. Khi mọc răng trẻ có thể sốt nhẹ, ăn kém, quấy khóc.
- **Bệnh lý:**
  - Nhu cầu cao nhưng tiêu hóa chưa hoàn chỉnh → dễ **rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng**.
  - Thần kinh chưa myelin hóa đủ, hưng phấn – ức chế lan tỏa → dễ **sốt co giật**.
  - **"Khoảng trống miễn dịch"** sau 6 tháng → tăng nguy cơ nhiễm trùng.
  - Hiếu động → tai nạn (ngạt nước, điện giật, ngộ độc). **Trầm cảm sau sinh** của mẹ ảnh hưởng nhận thức, hành vi của trẻ.
- **Phòng ngừa:** bú mẹ hoàn toàn **4–6 tháng đầu**, ăn dặm từ **tròn 6 tháng** song song bú mẹ, tiêm chủng đủ, theo dõi phát triển, tầm soát trầm cảm sau sinh.

4. THỜI KỲ RĂNG SỮA

- **Thời gian: 1–6 tuổi**: nhà trẻ (1–3 tuổi, tập đi, ngôn ngữ phát triển mạnh từ 18 tháng) và mẫu giáo (4–6 tuổi, hình thành nhân cách).
- **Sinh lý:** tăng trưởng **chậm lại**, trẻ thon gầy; mỗi năm tăng khoảng **2.000 g**. **4 tuổi** chiều cao gấp đôi lúc sinh (khoảng **1 m**); 6 tuổi não và vòng đầu gần bằng người lớn. Vốn từ tăng từ 50–100 lên **hơn 2.000 từ**.
- **Hoàn thiện hệ răng sữa:** đủ **20 răng sữa** trong khoảng **6–30 tháng**:

Tuổi	Răng sữa mọc
6–12 tháng	8 răng cửa
12–18 tháng	4 răng tiền hàm sữa
18–24 tháng	4 răng nanh sữa
24–30 tháng	4 răng hàm lớn sữa (răng cấm sữa)

- **Thói quen xấu và sâu răng:**
  - Nên **cai sữa lúc 12–15 tháng**; **không cho bú đêm** vì đường đọng quanh răng là nguyên nhân hàng đầu gây **sâu răng lan tỏa**.
  - Tuổi thích hợp để **tập chải răng**.
  - **Không mớm thức ăn** cho trẻ để tránh lây vi khuẩn gây sâu răng từ người lớn.
  - Tiếp tục cho ăn lỏng mềm như nhũ nhi dễ làm trẻ **chán ăn**.
- **Bệnh lý:** biếng ăn, hạ đường huyết nếu ăn đơn điệu, hoặc bị ép ăn, lạm dụng thuốc bổ; bệnh truyền nhiễm (sởi, ho gà, bạch hầu, uốn ván, sốt xuất huyết, viêm gan siêu vi) nếu chưa tiêm đủ; bệnh **dị ứng, tự miễn** (viêm cầu thận cấp, hen, mề đay); tai nạn, ngộ độc.
- **Phòng ngừa: muối iod**, tiêm chủng đủ, **khám răng định kỳ** (nha học đường), phòng tai nạn, diệt muỗi.

5. THỜI KỲ THIẾU NHI

- **Thời gian: 7–11 tuổi** (tuổi học đường); hoạt động chủ đạo chuyển từ **vui chơi sang học tập**.
- **Sinh lý:** tách dần khỏi bố mẹ, chơi theo nhóm bạn cùng giới; tư duy, phán đoán phát triển nhưng cảm xúc chưa ổn định.
- **Thay răng vĩnh viễn** (tổng **32 răng**), thứ tự gần giống mọc răng sữa:

Tuổi	Răng vĩnh viễn mọc
6–7 tuổi	4 răng hàm lớn thứ nhất (**răng số 6**, giữ khóa khớp cắn)
6–8 tuổi	4 răng cửa giữa
8–9 tuổi	4 răng cửa bên
9–10 tuổi	4 răng tiền hàm thứ nhất
12–14 tuổi	4 răng hàm lớn thứ hai
16–25 tuổi	4 răng hàm lớn thứ ba (răng khôn)

- **Bệnh lý:**
  - **Răng vĩnh viễn mọc lệch** nếu răng sữa sâu nặng không được điều trị hoặc nhổ đúng lúc (chân răng sữa nhiễm trùng không tiêu).
  - **Amidan phì đại** (amidan lúc này gấp đôi người lớn) → hẹp đường thở, **thở miệng kéo dài** → biến dạng vòm họng, lệch lạc khớp cắn (khớp cắn hở, hẹp xương hàm trên).
  - Bệnh răng miệng ở học sinh THCS **17,61%**; tật khúc xạ, bệnh ngoài da, giun, **vẹo cột sống** (bàn ghế không chuẩn); hen, viêm gan B, sốt xuất huyết, viêm màng não mô cầu; nói lắp, sa sút học tập.
- **Phòng ngừa:** vệ sinh cá nhân và học đường, **ánh sáng và bàn ghế đúng chuẩn**, giáo dục sức khỏe răng miệng, giáo dục giới tính, phát hiện sớm rối loạn ngôn ngữ, hành vi.

6. THỜI KỲ THIẾU NIÊN

- **Thời gian: 12–18 tuổi**, có thể đến **20 tuổi** (tuổi vị thành niên).

- **Sinh lý:** tuyến sinh dục hoạt động mạnh; não ít tăng cân nhưng chuyên biệt hóa vỏ não (thùy trán, đỉnh, thái dương).
  - **Dậy thì:** đặc tính sinh dục thứ phát, đánh giá bằng thang **SMR** hoặc **Tanner**.
  - Chiều cao tăng vọt: đỉnh **8–9 cm/năm ở nữ**, **9–10 cm/năm ở nam**; nhu cầu năng lượng **80–150 kcal/kg/ngày**.
  - Nữ có kinh nguyệt; nam mộng tinh, vỡ giọng, mọc râu. Tư duy trừu tượng phát triển, dễ kích động, muốn khẳng định mình.
- **Bệnh lý:**
  - **Răng khôn** mọc 16–25 tuổi: viêm lợi trùm, mọc ngầm, mọc lệch gây xô lệch răng trước. Bệnh răng miệng ở học sinh THPT **14,01%**.
  - **Thiếu vitamin C (scurvy)** ở nướu: nướu **tím xanh**, sưng, **dễ chảy máu** nhất là vùng răng cửa hàm trên.
  - Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong **thấp nhất** nhưng ngại đi khám.
  - **Nhi xã hội:** có thai ngoài ý muốn, nghiện, tự tử, bệnh lây qua đường tình dục; chống đối, trầm cảm, lo âu.
- **Phòng ngừa:** dịch vụ **"Sức khỏe trẻ vị thành niên"**, giáo dục giới tính và tránh thai an toàn, cha mẹ làm **"người bạn lớn"**, tầm soát trầm cảm, lo âu học đường.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế tài liệu gốc. Đối chiếu Các thời kỳ tuổi trẻ.pdf khi cần chi tiết.